Gestión de Muestras · 1er examen · Lo imprescindible

Tema 1 · Estructura organizativa del sector sanitario · Examen: 15.oct · Resumen de los 75 conceptos del Repaso: solo lo que más cae (rojo y azul)

1 · Sistema sanitario y salud

¿Sistema sanitario según la OMS? → Conjunto de elementos interrelacionados que contribuyen a la salud (hogares, trabajo, lugares públicos, comunidades).

¿5 principios de la OMS? → Universalidad (todos tienen derecho) · **Equidad** (a cada uno lo que **necesita**, no lo mismo) · **Eficiencia** (mejores resultados usando bien los recursos, no "gastar poco") · **Atención integral** (física, psicológica y social) · **Adaptación a las necesidades** (detectar y **prevenir**).

¿Salud según la OMS (1948)? → Completo bienestar físico, mental y social, y no solo ausencia de enfermedad.

¿Alma-Ata (1978)? → Salud = **derecho humano fundamental**; destaca la **atención primaria**.

¿Concepto ampliado? → La salud está condicionada por **factores sociales y capacidad de funcionamiento**.

2 · Determinantes de la salud

¿Modelo de Lalonde (1974)? → Estilo de vida 43 % (el que más) · **Biología 27 %** · **Medio ambiente 19 %** · **Sistema sanitario 11 %** (el que menos).

¿Biología / estilo de vida / medio ambiente / sistema sanitario? → Cómo somos (edad, sexo, genética) / **lo que hacemos** (dieta, tabaco, ejercicio) / **lo que nos rodea** (medio **físico** y **social**) / **la atención que recibimos**.

¿Los estilos de vida dependen solo de la persona? → No: las condiciones sociales y económicas facilitan o dificultan los hábitos.

¿Dahlgren y Whitehead (1991)? → Capas concéntricas alrededor de la persona; **cuanto más externa la capa, menos depende de la persona**.

¿Países ricos vs pobres? → Ricos: **enfermedades crónicas**. Pobres: **infecciosas y mortalidad infantil**.

3 · Qué hace el sistema y cómo se organiza

¿Actúa solo cuando enfermamos? → No: protege, mantiene y recupera la salud.

¿5 actuaciones? → Prevención · detección precoz · tratamiento · rehabilitación · promoción de la salud.

¿Por qué cada país lo organiza distinto? → Distinta situación **económica, política, social y cultural**.

¿Modelos sanitarios? → Los **criterios doctrinales e ideológicos** de cada sistema.

¿3 preguntas de todo sistema? → ¿Quién paga? (financiación) · **¿quién presta?** (provisión) · **¿quién lo usa?** (acceso).

4 · Modelos sanitarios

Modelo	Quién paga	Acceso	Ejemplo	Lo clave
Liberal	Seguro privado / individuo	Según **dinero o póliza**	**EE. UU.**	**Avances tecnológicos**; **sin universalidad ni equidad**; esperanza de vida menor
Social (Semashko)	**Estado (todo)**	**Universal y gratuito**	**Cuba** (antes URSS, 1917)	Profesionales = empleados públicos; vacunaciones masivas; regímenes no democráticos
Mixto	Estado + privado	—	**Mayoría de países occidentales**	Calidad asistencial; **promoción, prevención y primaria**; 2 variantes
Bismarck	**Cotizaciones**	Trabajadores (+ **beneficencia**)	**Alemania 1883**, Francia	**Mutualista**; quien no trabajaba quedaba desprotegido
Beveridge	**Impuestos**	**Universal**	**Reino Unido** (1942→NHS 1948), **España**	Se puede concertar con privados; **listas de espera**

¿Qué modelo sigue España? → Beveridge. Antes era **Bismarck**; el cambio empezó con la **Ley General de Sanidad de 1986**.

5 · El SNS en España

¿Leyes clave?

- **Constitución 1978, art. 43 → derecho a la protección de la salud**.
- **Ley 14/1986 General de Sanidad → crea el SNS**.
- **Ley 16/2003 de cohesión y calidad → cartera común** en todas las CC. AA.
- **RDL 16/2012** → restringe a "asegurados" y amplía el copago.
- **RDL 7/2018 → recupera la universalidad** (por **residencia**).

¿Salud como derecho fundamental (internacional)? → Constitución de la OMS, 1946.

¿7 principios del SNS? → Universal · equitativo · financiado con fondos públicos · gratuito en el uso · integral · de calidad · descentralizado.

¿Quién reparte competencias? → La **Constitución** (arts. 148 y 149). **Estado:** bases, medicamentos, **sanidad exterior**. **CC. AA.: gestionan la asistencia** (Navarra: **Osasunbidea**). **Ceuta y Melilla: INGESA**.

¿Consejo Interterritorial? → **Conecta Estado y CC. AA.** (Ministerio + consejeros).

¿AEMPS? → Agencia de Medicamentos; **depende del Ministerio de Sanidad**; vigilancia tras la venta = **farmacovigilancia**.

¿Tarjeta Sanitaria Europea? → Asistencia en estancias temporales en la UE; con otros países, **convenios bilaterales**. Epidemias: **OMS y ECDC**.

6 · Organización asistencial y cartera

¿Atención primaria? → **Puerta de entrada**; prevención y problemas frecuentes; **acompaña toda la vida**.

¿Atención especializada? → Hospitales; llega **derivado**; aquí está **Anatomía Patológica**; luego **vuelve a primaria**. Función propia: **servicio de medios**.

¿Organización territorial? → **Áreas de salud** (hospital de referencia) → **zonas básicas** (centro de salud). Te toca según dónde estás **empadronado**; **tarjeta sanitaria individual**.

¿Cartera de servicios? → **Técnicas, tecnologías y procedimientos que ofrece el SNS** (Ley 16/2003 y **RD 1030/2006**). **Básica = gratuita**; **suplementaria = con aportación**; **complementaria = de cada CC. AA.**

¿Salud pública? → Protege la salud de **toda la comunidad**; incluye **cribados** de mama, cérvix y colorrectal.

¿Triaje? → **Clasifica la prioridad según la gravedad** (enfermería), **5 niveles**; **todos son atendidos**.

¿Medicamentos? → **La AEMPS autoriza; el Ministerio decide la financiación y el precio.**

¿Prótesis vs ortesis? → Prótesis **sustituye** (cadera); ortesis **corrige o apoya** (férula, corsé).

7 · Deontología y bioética

¿Código deontológico? → **Principios éticos y normas de conducta** de los profesionales; **no siempre legalmente vinculante**.

¿Bioética? → Engloba **ética, deontología y derecho**; término de **Van Rensselaer Potter (1971)**.

¿4 principios (Beauchamp y Childress)? → **Autonomía** (consentimiento informado, **Ley 41/2002**) · **Justicia** (sin discriminación) · **Beneficencia** (hacer el bien) · **No maleficencia** (no hacer daño).

¿Código de Deontología Médica? → **2011**; 3 bloques: **comportamiento del médico**, **relación con otras profesiones**, **relación con el sistema sanitario**. Novedades: historia

clínica informatizada, protección de datos, seguridad del paciente, combatir la violencia, relación médico-paciente, formación continua.

8 · LOPS

¿Qué es? → **Ley 44/2003**: regula **a las personas** (profesiones sanitarias, pública y privada) para que estén **cualificadas**. La LGS de 1986 crea **el sistema**.

¿Dos grupos de profesionales? → **A. Titulados universitarios (art. 2)** y **B. Formación profesional (art. 3)**. El **TS en Anatomía Patológica** está en **FP**.

¿Trabajo en equipo según la LOPS? → **Interdisciplinar, basado en la cooperación y no en la jerarquía**; seguir **guías y protocolos**; **formación continuada**.

¿Etapas de formación? → **Pregrado · especializada (MIR, BIR…) · continuada · desarrollo profesional.**

9 · Economía y sostenibilidad

¿Futuro de la población? → **Envejecida**, con enfermedades antes mortales ahora **crónicas**.

¿Hacia dónde van las mejoras? → Gestionar recursos humanos y financieros · **sostenibilidad** · atención integral · **herramientas digitales** · formación más fluida.

¿Economía de la salud? → Repartir **recursos limitados** para el **máximo nivel de salud**.

¿Eficacia / efectividad / eficiencia? → Funciona en **condiciones ideales** / en la **práctica real** / **mejor resultado al menor coste**.

¿Gasto sanitario? → Crece más que los recursos; España ≈ **10 % del PIB**. Mayor partida: **personal**. España: **líder en donación de órganos (ONT)**.

¿Por qué el diagnóstico precoz ahorra? → El **diagnóstico tardío es mucho más caro**; la **Anatomía Patológica es clave**.

10 · Calidad y evaluación

¿Calidad (Ley 16/2003)? → **Hacer lo correcto, de la forma correcta, en el momento adecuado, al paciente adecuado, con seguridad y al menor coste.**

¿Calidad según Donabedian (1980)? → La que da al usuario el **máximo y más completo bienestar** tras valorar el **balance de ganancias y pérdidas**. Dimensiones: **estructura, proceso y resultado**.

¿Tipos de costes? → **Directos** (por la atención: consultas, fármacos) · **Indirectos** (por la enfermedad: **pérdida de productividad**, cuidado informal) · **Intangibles** (**los más difíciles de medir**: dolor, ansiedad, calidad de vida).

¿Modelos de gestión de calidad más usados en salud? → **EFQM, Euskalit, ISO 9001:2015 y Joint Commission.**

¿Ciclo de Deming (PDCA)? → **Planificar → Hacer → Verificar → Actuar.**

¿Evaluaciones económicas? → **ACB:** costes vs beneficios **en €** · **ACE:** costes vs resultados en salud · **ACU:** costes vs **QALY** · **ACM:** dos tratamientos **igual de efectivos → el más barato**.

Las 15 que no puedes fallar

1. 5 principios de la OMS (**equidad ≠ igualdad**).
2. Salud OMS 1948 y Alma-Ata 1978.
3. Lalonde: **43-27-19-11**.
4. Liberal = EE. UU., avances, sin universalidad.
5. Social = Estado todo, **Cuba**.
6. Bismarck = **cotizaciones**, Alemania 1883.
7. Beveridge = **impuestos**, Reino Unido → **España**.
8. Art. 43 CE · LGS 1986 crea el SNS · Ley 16/2003 cartera · RDL 7/2018 universalidad.
9. CC. AA. gestionan la asistencia · Consejo Interterritorial · INGESA.
10. Primaria = puerta de entrada · **Anatomía Patológica en especializada**.
11. Triaje = prioridad por gravedad, 5 niveles.
12. Bioética: autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia.
13. LOPS 2003: TS en AP = **formación profesional**.
14. Costes directos / indirectos / **intangibles** (los más difíciles).
15. ACB (€), ACE, ACU (QALY), ACM (el más barato) · Deming PDCA.